

Tabagisme

Dr BOUHANT

Dr BOUHANT maitre-assistant en Pneumo-phthysologie / HMRUC

Plan :

- I. Introduction
- II. Epidémiologie
- III. Considérations générales :
- IV. Pathologies liées au tabac
- V. Prise en charge thérapeutique
- VI. Aide médicale à l'arrêt du tabagisme
- VII. Prévention et lutte anti-tabac
- VIII. Conclusion

Stratégie d'apprentissage : Cours magistral

Compétences à acquérir

Objectifs :

- 01. Situer l'importance du tabagisme dans le monde et en Algérie (prévalence, morbi mortalité et coût)
- 02. Enumérer les principaux toxiques de la fumée de tabac
- 03. Expliquer les mécanismes physiopathologiques de la toxicité de la fumée de tabac sur l'appareil respiratoire et les autres organes.
- 04. Décrire le mode d'action de la nicotine
- 05. Enumérer les différentes manifestations respiratoires et extra-respiratoires liées au tabac
- 06. Chiffrer la consommation cumulée de tabac chez un fumeur
- 07. Evaluer la dépendance du tabagisme (test Fargenstrom)
- 08. Citer les principales mesures de lutte antitabac à l'échelle collective et individuelle
- 09. Situer le rôle du médecin généraliste dans la prévention et la prise en charge du fumeur.

I. Introduction :

Le terme « tabagisme » est à l'origine un terme médical désignant l'intoxication aiguë ou chronique provoquée par l'abus du tabac. Par extension, il désigne également la consommation de tabac en général.

Malgré les campagnes annuelles contre le tabagisme et les augmentations des prix, les ventes totales de tabac ne baissent pas et le nombre de fumeurs tend dans le même temps à croître, en particulier chez les femmes.

- Le tabagisme reste un fléau mondial, responsable d'une lourde morbi-mortalité.
- Il représente un problème majeur de santé publique, coûte cher à la société et il est la première cause de mortalité évitable.

II. Epidémiologie :

1. Dans le monde

-1.7 milliard en 2020 - 2025.

- Hommes: 1 milliard
35% dans les pays développés
50% dans les pays en développement
- Femmes: 250 millions
22% dans les pays développés
9% dans les pays en développement

- Ce chiffre atteindra 10 millions par an en 2030, avec 70% de morts dans les pays en développement.

- Le tabagisme est plus fréquent chez les personnes à faible revenu.

2. En Algérie

L'enquête nationale de santé (projet TAHINA 2005) retrouve une estimation globale de 11 % parmi une population générale âgée de 35 à 70 ans.

L'enquête réalisée à Alger par Nafti et col sur des élèves âgés de 6 à 20 ans retrouve 5,5% de fumeurs.

La consommation annuelle de tabac s'élève à 25000 tonnes, avec un accroissement annuel de 5%par an.

La consommation de tabac a triplé au cours de ces dernières décennies, 28% en 2005.

III. Considérations générales

1. Différentes formes de tabac fumé

- Les cigarettes industrielles.
- Le tabac à rouler, à chiquer.
- Cigares et pipes.
- La pipe à eau, ou narguilé, ou chicha

2. Composition de la fumée de cigarette

Il existe plusieurs courants de fumée :

- Le courant principal (primaire) qui correspond à la fumée directement inhalée par le fumeur,
- Le courant latéral (secondaire), qui correspond à la fumée produite par une cigarette se consumant seule en l'absence d'inhalation du fumeur.
- Le courant tertiaire (fumée exhalée par le fumeur, celle-ci ayant été en grande partie << filtrée >> dans les poumons), est à l'origine du tabagisme environnemental.

Plus de 4 000 substances

- Phase gazeuse :

Gaz carbonique; monoxyde de carbone (CO); cyanide d'hydrogène; composés organiques volatiles (aldéhydes, cétones, ammoniac).

- Phase particulaire : 0,1 et 1 μm de diamètre (pénétration dans les alvéoles)
 - o les substances cancérogènes : hydrocarbures polyaromatiques (benzopyrènes), dérivés nitrés hétérocycliques (pyridine), aldéhydes, nitrosamines, cétones, etc. ;
 - o irritants : acroléines ;
 - o métaux : nickel, cadmium;
 - o radicaux libres : quinones, époxydes, composés peroxydes ;
 - o nicotine.

3. Dépendance au tabac

Les envies de fumer sont modulées par l'interaction entre, d'une part, les expériences psychoémotionnelles liées à la consommation de tabac et, d'autre part, la dépendance nicotinique.

La nicotine, induit rapidement une dépendance chez le consommateur.

Après l'inhalation d'une bouffée de fumée de tabac, de grosses quantités de nicotine arrivent rapidement au cerveau (7 secondes) où elles vont se fixer sur des récepteurs cholinergiques dits << nicotiques >> et facilite la libération de neurotransmetteurs, en particulier la dopamine.

Le plaisir ressenti alors par le fumeur renforce son comportement.

Au bout de quelque temps, il fume pour retrouver ces effets agréables de la nicotine (renforcement positif) et également pour éviter les effets désagréables liés à son manque (renforcement négatif)

Le test de Fagerström permettant d'avoir un bon reflet de la dépendance.

Tableau 1 Test de dépendance à la nicotine (test de Fagerström - 1991) [67].		
Questions	Réponses	Scores
1 - Dans quel délai après le réveil fumez-vous votre première cigarette ?	Moins de 5 minutes	3
	6 à 30 minutes	2
	31 à 60 minutes	1
	Après 60 minutes	0
2 - Trouvez-vous difficile de ne pas fumer dans les endroits où c'est interdit ?	Oui	1
	Non	0
3 - Quelle cigarette trouvez-vous la plus indispensable ?	La première	1
	Une autre	0
4 - Combien de cigarettes fumez-vous par jour ?	10 ou moins	0
	11 à 20	1
	21 à 30	2
	31 ou plus	3
5 - Fumez-vous de façon plus rapprochée dans les premières heures après le réveil que pendant le reste de la journée ?	Oui	1
	Non	0
6 - Fumez-vous-même si une maladie vous oblige à rester au lit ?	Oui	1
	Non	0
Interprétation		
Score de 0 à 3 : peu ou pas de dépendance		
Score de 4 à 6 : dépendance moyenne		
Score de 7 à 10 : forte dépendance		
Score de 9 à 10 : très forte dépendance		

4. Quantification du tabagisme

- Age de début du tabagisme
- Importance actuelle du tabagisme
- Durée du tabagisme

- Quantité totale de tabac fumé : Les conséquences pathologiques en dépendent directement et elle est estimée en « paquets-années ».

Par exemple : pour 10 cigarettes fumées par jour pendant 20 ans (soit 10 Milligrammes de tabac par jour), le nombre de paquets-années sera égal à $1/2 \times 20$, soit 10 paquets-années.

5. Status tabagique : Pour définir le statut fumeur d'un individu, il est conseillé de suivre les définitions suivantes :

Un non(jamais)-fumeur est une personne ayant fumé moins de 100 cigarettes au cours de sa vie.

Un ex-fumeur (ou fumeur sevré) a stoppé totalement et définitivement son tabagisme depuis plusieurs mois. Le délai le plus communément admis est 12 mois.

Un fumeur actif est un fumeur non sevré depuis 12 mois.

6. Syndrome de sevrage : présence d'au moins 4 des facteurs suivants :

- Humeur dépressive.
- Insomnie.
- Irritabilité, frustration colère.
- Anxiété.
- Difficulté de concentration.
- Agitation.
- Ralentissement du pouls.
- Augmentation de l'appétit et / ou prise de poids rapide.

Examens para cliniques :

- Testeur de Co : Il permet d'évaluer en ppm le Co et d'apprécier le niveau du tabagisme.
Il renforce la motivation en cours de sevrage.
- Nicotinémié : sans intérêt en pratique courante.
- Cotininémié.

IV. Pathologies liées au tabac :

1. Pathologies cancéreuses :

Tabagisme actif responsable de 90 % des cancers broncho-pulmonaires.

Tabagisme passif responsable de 25 % des cancers broncho-pulmonaires chez les non-fumeurs.

Egalement responsable des cancers des voies aéro-digestives supérieures (cavité buccale, pharynx, larynx, oesophage)

Action synergique de l'alcool et du tabac.

Il est également responsable des cancers de la vessie, du pancréas, du rein et du col de l'utérus.

2. Pathologies respiratoires :

- BPCO : 3,5 millions de personnes sont touchées en France dont 2/3 l'ignorent.
- 17 000 décès chaque année
- effet bénéfique du sevrage sur la survie, en diminuant le taux d'infections respiratoires et le déclin du VEMS
- Asthme : le tabac favorise les exacerbations et est un facteur de mauvais contrôle de l'asthme.

3. Maladies cardio-vasculaires :

- Cardiopathies ischémiques
- Artérite
- Hypertension artérielle (HTA)
- Maladies cérébro-vasculaires

Relation tabac-athérome. Le CO entraîne :

- Hypoxie de l'intima.
- Ischémie et augmentation de la perméabilité endothéliale.
- Lésions endothéliales.
- Vasoconstriction par libération de catécholamines.

Dans la maladie coronaire, le tabac entraîne :

- Augmentation du risque thrombotique.
- Stimulation adrénergique par la nicotine
- Vasoconstriction, hypoxie endothéliale.
- Troubles du métabolisme lipidique.
- Effets arythmiques.

4. Autres pathologies :

- Digestives : ulcère, oesophage, pancréas...
- La dégénérescence maculaire responsable de cécité.
- Les kératites, en particulier chez les porteurs de lentilles de contact.
- L'acné juvénile.
- Les retards de cicatrisation.
- Le retard à la consolidation osseuse après chirurgie, responsable de pseudarthroses.
- L'agueusie (perte du goût), l'anosmie (perte de l'odorat).

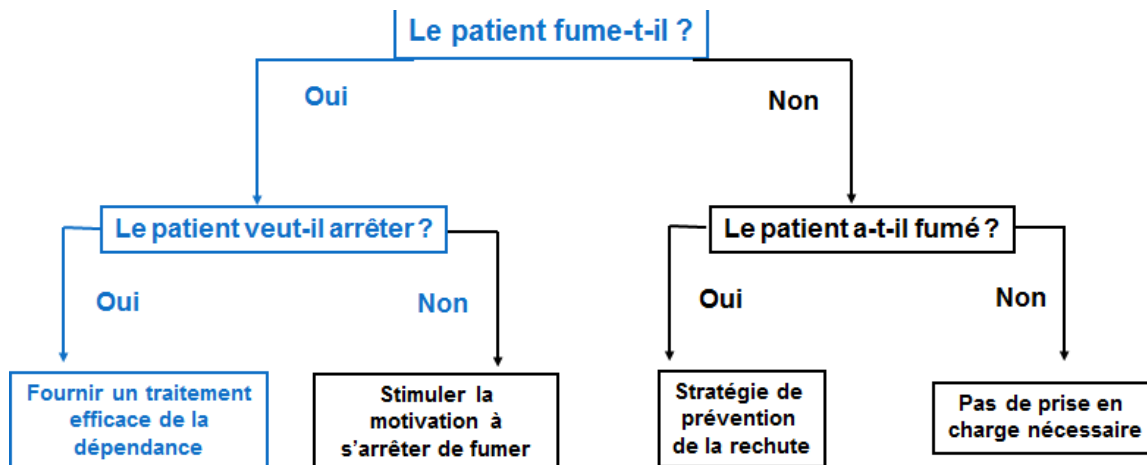
5. Risques liés au tabagisme passif :

- Augmentation de 25 % du risque de cancer bronchique.
- Augmentation de l'ordre de 25% de maladies cardio-vasculaires. Ces accidents cardiovasculaires représentent 4/5 des victimes du tabagisme passif.
- Aggravation des asthmes et BPCO.
- Augmentation du risque d'infections respiratoires chez le nourrisson, hautes (rhinopharyngites, otites,..) et basses (bronchites, bronchiolites, broncho-pneumopathies).
- Augmentation du risque de retard de croissance intra-utérin
- Le tabagisme est actuellement la 1ère cause identifiée de mort subite du nourrisson (tabagisme actif de la femme enceinte et de la jeune mère, l'exposition de la femme enceinte au tabagisme passif et le tabagisme paternel)

V. Prise en charge thérapeutique

1. Le conseil minimal

Il est donné par un professionnel de la santé lors d'une consultation pour un motif autre que le tabagisme, en dehors de toute demande de sevrage de la part du patient, son but est de permettre la maturation de la décision d'arrêter. Il consiste à demander systématiquement à chaque patient s'il est fumeur et s'il a envisagé la possibilité de s'arrêter de fumer.



2. La consultation de sevrage

S'adresse à des patient motivés et volontaires par des médecins spécialistes ou généralistes formés en tabacologie.

3. Traitements pharmacologiques

1) Traitement de substitution nicotinique : Il comprend

- les patchs (timbres) transdermiques, 21, 14, 7 mg/24h ; 15, 10, 5 mg/16h
- les gommes à mâcher, 2 et 4 mg (maxi 60 mg / j)
- les comprimés à sucer,
- l'inhaleur
- le spray nasal.
- Tablettes sublinguales

Durée : 6 semaines à 6 mois

2) Bupropion (Zyban®)

Il s'agit d'un antidépresseur atypique : c'est un inhibiteur de la recapture dopaminergique et noradrénergique.

3) Varénicline (Champix®)

Agoniste partiel du récepteur nicotinique.

2. Thérapies comportementales

- 1) Entretiens motivationnels
- 2) Thérapie cognitive et comportementale
- 3) Gestion des contingences

VI. Aide médicale à l'arrêt du tabagisme

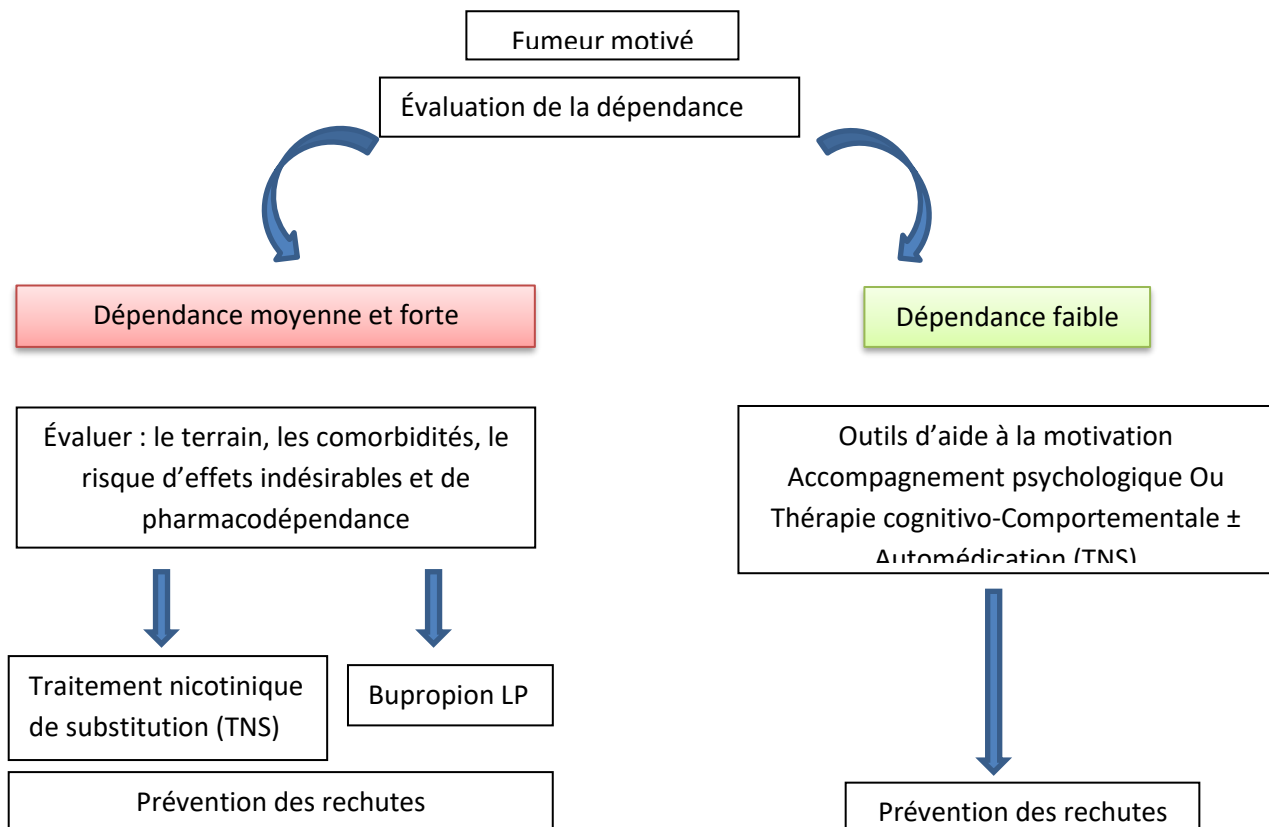
1. Conduite du sevrage :

Dépend du niveau de dépendance nicotinique scoré par le test de Fagerström

1- dépendance faible : La conduite à tenir se base sur plusieurs paliers au fur et mesure de l'échec d'une méthode

2- Dépendance moyenne et forte

1. Evaluer le terrain : alcoolisme, drogues dures, maladie psychiatrique
2. Chercher les comorbidités : BPCO, Cardiopathie,
3. Evaluer les risques des effets indésirables du sevrage
4. Conduite du sevrage :
 - Renforcer les motivations
 - Accompagnement psychologique
 - Traitements pharmacologiques



Effets secondaires du sevrage tabagique

- Les troubles anxio-dépressifs
- Les troubles du sommeil (insomnie ou hypersomnie)
- Le ralentissement du transit intestinal à corriger par l'apport de fibres alimentaires ou par des régulateurs de la motricité intestinale
- La prise de poids

VII. Prévention et lutte anti-tabac

1. Prévention ; a pour objectif d'obtenir la diminution du pourcentage de fumeurs dans la population adulte et d'empêcher le début du tabagisme chez l'enfant et l'adolescent,

2. lutte anti-tabac ; c'est un but difficile à atteindre quel que soit le pays car cette lutte fait appel à la bonne volonté de plusieurs catégories de profession.

L'efficacité de cette lutte ne peut être espérée que si elle s'exerce parallèlement à trois niveaux :

a) lutte au niveau individuel :

- informer sur les effets nocifs du tabac.
- supprimer la dépendance pharmacologique.
- agir sur la dépendance psychosociale.

b) lutte au niveau collectif: 2 populations à cibler en priorité

- le milieu professionnel.
- le milieu scolaire.

Au niveau législatif: de nombreuses mesures sont prises:

- Augmentation des taxes et des impôts....prix des cigarettes.
- Publicités interdites,
- Séparation : coins fumeurs et non-fumeurs dans les lieux publics.

VIII. Conclusion :

Le tabagisme n'est pas une maladie mais un comportement. Il est la cause de multiples maladies (cancers- AVC-BPCO-...).

Plusieurs points forts sont à retenir :

- Rajeunissement de l'âge de début et la féminisation du tabagisme.
- Le tabac est la première cause de mortalité prématurée et de morbidité évitable :

1 fumeur sur 2 meurt d'une maladie liée au tabac

1 fumeur sur 4 meurt prématurément (avant 65 ans).

Références :

- 1- GUIDE PRATIQUE, Le tabagisme de la dépendance au sevrage, Le Module de Tabacologie 2007
- 2- Item 73 Addiction au tabac. Référentiel ECN Collège des Enseignants de Pneumologie – 2023
- 3- Thomas D. Tabagisme et prise en charge des fumeurs. EMC - Angéiologie 2021;25(1):1-17.
- 4- Conduite du sevrage tabagique, L. Karila, P. Dupont EMC Pneumologie 2011
- 5- Wirth N, Berlin I, Martinet Y. Consommation de tabac et maladies respiratoires. EMC - Pathologie professionnelle et de l'environnement 2019;14(4):1-12.